

- Identification du souscripteur et des bénéficiaires.
- Effectif et structure de la population pour un collectif.
- Historique de sinistralité lorsque disponible.
- Garanties antérieures et conditions de renouvellement.
- Territorialité et fréquence des déplacements.
- Activité de l'entreprise et caractéristiques de la population.
- Modalités de paiement et conditions de prise d'effet.
- Pièces administratives et justificatifs requis.

3. Analyse du risque collectif

Le nombre de personnes ne suffit pas. Étudier âge, composition familiale, activité, localisation, historique de consommation, gros sinistres, fréquence, coût moyen et garanties. Deux groupes de 500 personnes peuvent avoir des profils techniques très différents.

4. Indicateurs techniques

S/P = sinistres / primes. Exemple : 68 M FCFA de sinistres pour 120 M FCFA de primes = 56,67 %. Pour aller plus loin : fréquence = nombre d'actes / nombre de personnes ; coût moyen = montant des sinistres / nombre de sinistres ou actes, selon la définition retenue.

5. Matrice de garanties

Garantie	Taux	Plafond	Franchise	Entente préalable
Consultation	80 %	Selon contrat	Selon contrat	Non/selon contrat
Pharmacie	80 %	500 000/an	Selon contrat	Non
Hospitalisation	90 %	5 000 000/an	Selon contrat	Oui/selon contrat
Optique	100 %	150 000/an	Selon contrat	Selon contrat
Dentaire	80 %	200 000/an	Selon contrat	Selon contrat
EVASAN	Selon contrat	Selon contrat	Selon contrat	Oui

6. Émission

- Contrôler l'acceptation finale.
- Paramétrer correctement les garanties avant l'activation.
- Créer le contrat et ses populations.
- Définir les dates d'effet et d'échéance.
- Enregistrer les conditions de paiement.
- Émettre police/attestation et supports prévus.
- Archiver la preuve des validations.

PARTIE IV — ASSURÉS, AYANTS DROIT ET MOUVEMENTS

1. Cycle de vie d'un assuré

Création → activation → utilisation → modification → suspension éventuelle → sortie/radiation → archivage. Pour un collectif : entrées, sorties, naissance, mariage, changement de catégorie, changement d'option.

2. Contrôle d'une affiliation

- Identifier le contrat et la catégorie.
- Vérifier la date d'effet.
- Contrôler le lien avec le titulaire.
- Contrôler les pièces requises.
- Vérifier les éventuels délais d'attente.
- Activer uniquement les garanties réellement souscrites.
- Tracer la personne ayant validé l'affiliation.

3. Cas pratique — entrée d'un salarié

Un salarié rejoint l'entreprise le 10 septembre. La demande d'affiliation est reçue le 15 septembre. Le gestionnaire ne choisit pas arbitrairement la date d'effet : il applique la règle prévue au contrat ou au protocole collectif. Si la couverture est rétroactive, le système doit tracer cette rétroactivité et ses conditions.

4. Radiation

Vérifier date de sortie, règles de maintien éventuel, prestations engagées, cartes/supports, soldes et information des parties. Une radiation ne doit pas effacer l'historique des prestations.

PARTIE V — GESTION DES PRESTATIONS ET SINISTRES

1. Workflow standard

Réception → identification → droits → acte → garantie → pièces → base/tarif → taux → plafond/franchise → contrôle médical si nécessaire → liquidation → validation → paiement → comptabilisation → archivage.

2. Contrôle des droits

- Contrat actif à la date des soins.
- Personne couverte et correctement rattachée.
- Garantie disponible.
- Plafond non épuisé ou solde calculé.
- Absence de suspension applicable.
- Prestataire et canal de prise en charge conformes au contrat.

3. Contrôle de la facture

- Identité du patient.
- Date des soins.
- Prestataire.
- Nature et quantité des actes.
- Prescription ou justificatifs requis.
- Tarif applicable.
- Éléments exclus.
- Concordance entre facture, ordonnance et prise en charge.

4. Base de remboursement

La base facturée et la base admissible peuvent différer. Exemple : facture 100 000 FCFA, base admissible 60 000 FCFA, taux 80 % → remboursement 48 000 FCFA, sous réserve des plafonds et règles contractuelles.

5. Plafonds

Exemple : plafond pharmacie annuel 500 000 FCFA ; consommation antérieure 450 000 FCFA ; nouvelle dépense admissible 100 000 FCFA. Solde de plafond = 50 000 FCFA. À 80 %, remboursement = 40 000 FCFA, si aucune autre règle ne modifie le calcul.

6. Franchises

Ne jamais supposer le mode d'application. Une franchise peut être exprimée en montant, pourcentage, par acte, par période ou selon une autre modalité. La règle exacte du contrat prime.

7. Rejet

Un rejet doit être motivé, traçable et compréhensible : prestation non couverte, droit fermé, plafond épuisé, pièce obligatoire absente, dépassement d'une limite contractuelle, etc. Une anomalie doit déclencher un contrôle ; elle ne constitue pas automatiquement une fraude.

PARTIE VI — CONTRÔLE MÉDICAL, FRAUDE, ABUS ET INDUS

1. Contrôle médical

Le médecin-conseil peut intervenir sur la nécessité médicale, la cohérence d'un traitement, une hospitalisation, une chirurgie, une EVASAN, une demande coûteuse ou un dossier complexe. Le gestionnaire administratif ne doit pas se substituer au médecin pour une appréciation médicale.

2. Signaux d'alerte

- Répétitions inhabituelles d'actes.
- Factures identiques ou séquences incohérentes.
- Quantités anormalement élevées.
- Prestations incompatibles dans le temps.
- Utilisation accélérée d'un plafond.
- Facturation inhabituelle d'un prestataire.
- Discordance entre ordonnance et facturation.

3. Méthode de traitement

Détecter → documenter → suspendre si la procédure le permet → demander les justificatifs → contrôle médical/administratif → décider → notifier → récupérer un éventuel indu selon les règles applicables → tracer.

4. Indus

Un paiement erroné doit être identifié, documenté et traité selon une procédure de récupération validée. Le dossier doit conserver le montant initial, le montant correct, l'écart, la cause et la décision.

PARTIE VII — HOSPITALISATION, GROS RISQUES ET EVASAN

1. Hospitalisation

- Vérifier droits et garantie.
- Vérifier si entente préalable requise.
- Analyser devis ou demande médicale.
- Déterminer le plafond disponible.
- Émettre l'accord selon les limites autorisées.
- Suivre les prolongations.
- Contrôler la facture finale et les actes.

2. Exemple

Facture admissible : 2 000 000 FCFA ; taux : 90 % ; plafond disponible : 5 000 000 FCFA. Prise en charge théorique : 1 800 000 FCFA. Si 200 000 FCFA correspondent à des éléments exclus, ils doivent être retranchés avant le calcul.

3. Gros sinistres

Mettre en place des seuils d'alerte internes : par exemple, signalement à partir d'un montant défini par l'assureur. Suivre cumul annuel, plafond, réassurance, évolution médicale et exposition restante.

4. EVASAN — procédure de référence

Demande médicale → réception → vérification des droits → vérification de la garantie EVASAN → appréciation médicale → analyse de la disponibilité des soins selon les règles contractuelles → recherche/validation de l'établissement → devis → validation financière → prise en charge → organisation → suivi → facturation → clôture.

5. Règle de gouvernance

Séparer autant que possible : décision médicale, décision administrative et décision financière. Toute dérogation doit être autorisée et tracée.

PARTIE VIII — COMPTABILITÉ, RÈGLEMENT ET RAPPROCHEMENTS

1. Chaîne financière

Prestation reçue → dette identifiée → liquidation → validation → ordre de paiement → règlement → rapprochement → comptabilisation → clôture.

2. Contrôles avant paiement

- Identité et coordonnées du bénéficiaire du paiement.
- Montant validé.
- Absence de doublon.
- Validation conforme au seuil de délégation.
- Pièces présentes.
- Compte bancaire ou moyen de paiement contrôlé.
- Rapprochement avec le dossier de sinistre.

3. Contrôle des doublons

Comparer au minimum : assuré, prestataire, date, numéro de facture, montant, nature de l'acte et référence de prise en charge. Un doublon potentiel doit être mis en contrôle avant règlement.

4. Rapprochement

Le total des sinistres liquidés doit pouvoir être rapproché des règlements et des engagements comptables. Les écarts doivent être expliqués, non simplement masqués.

PARTIE IX — PILOTAGE TECHNIQUE ET RENOUVELLEMENT

1. Tableau de bord minimum

Indicateur	Formule / lecture
S/P	Sinistres / primes
Fréquence	Nombre d'actes / population ou assurés exposés
Coût moyen	Montant des sinistres / nombre de sinistres, selon définition
Consommation par tête	Prestations / nombre de bénéficiaires exposés
Délai moyen	Temps moyen entre réception complète et liquidation
Taux de rejet	Dossiers rejetés / dossiers traités
Gros sinistres	Nombre et montant au-dessus d'un seuil interne

2. Analyse de renouvellement

Ne pas décider uniquement à partir du S/P. Étudier : évolution des effectifs, mix de population, inflation médicale, dérive des actes, gros sinistres, garanties, réseau, frais, commissions, réassurance et qualité des données.

3. Exemple

Primes annuelles : 120 M FCFA. Sinistres : 68 M FCFA. $S/P = 56,67 \%$. Si la structure de garanties a été renforcée en cours d'année ou si des sinistres importants sont encore en attente, l'analyse doit être ajustée.

4. Renouvellement

- Produire le compte technique.
- Analyser les écarts avec l'exercice précédent.
- Identifier les garanties déficitaires.
- Quantifier les facteurs de dérive.
- Proposer ajustement de garanties, réseau ou tarif.
- Présenter plusieurs scénarios.
- Obtenir validation avant émission du renouvellement.

PARTIE X — DIGITALISATION ET SYSTÈME D'INFORMATION SANTÉ

1. Architecture fonctionnelle

Référentiel clients → contrats → groupes → assurés → garanties → prestataires → actes → prises en charge → factures → liquidation → paiements → comptabilité → reporting.

2. Règles à automatiser

- Vérification automatique des droits.
- Calcul du plafond disponible.
- Application des taux.
- Détection de doublons.
- Alertes gros sinistres.
- Entente préalable.
- Workflow de validation.
- Journal d'audit.
- Gestion des habilitations.
- Historisation des modifications.

3. Numérique et zone CIMA

La CIMA dispose d'un règlement spécifique sur la distribution et la gestion du contrat d'assurance par voie numérique/électronique. Un système santé doit donc être conçu avec traçabilité, sécurité, contrôle des accès, conservation des preuves et continuité d'activité, en cohérence avec les textes applicables et les politiques internes.

4. Principe de conception

Le logiciel ne doit pas seulement enregistrer une décision ; il doit être capable d'expliquer pourquoi la décision a été prise. Chaque liquidation importante devrait être reconstituée à partir des données, règles, versions de garanties et validations utilisées.

PARTIE XI — PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES ET CHECK-LISTS

Procédure A — Création d'un contrat collectif

Étape	Contrôle	Preuve attendue
1	Dossier client complet	Dossier administratif
2	Population analysée	Fichier assuré
3	Garanties validées	Tableau de garanties
4	Tarif validé	Note / offre
5	Conditions acceptées	Police / avenant
6	Contrat créé	Référence système
7	Garanties paramétrées	Capture / journal
8	Population affiliée	Liste validée
9	Mise en vigueur	Preuve date d'effet

Procédure B — Liquidation d'une prestation

Étape	Question	
1	Qui ?	Assuré et bénéficiaire
2	Quand ?	Date des soins
3	Quoi ?	Acte identifié et autorisé
4	Où ?	Prestataire/can
5	Combien ?	Base admissible
6	Quel taux ?	Taux applicable
7	Quel plafond ?	Solde disponible
8	Quelle franchise ?	Règle appliquée
9	Quel contrôle ?	Pièces / médicaux
10	Combien payer ?	Montant final ju

Procédure C — Dossier en anomalie

Ne pas payer → qualifier l'anomalie → demander les pièces → contrôler → décider → documenter → notifier → clôturer ou escalader.

PARTIE XII — CAS PRATIQUES CORRIGÉS

Cas 1 — Consultation simple

Données : facture 25 000 FCFA ; taux 80 % ; pas de plafond atteint. Solution pédagogique : si la base admissible est 25 000 FCFA, remboursement = 20 000 FCFA ; reste assuré = 5 000 FCFA.

Cas 2 — Base différente du facturé

Données : facture 100 000 FCFA ; base admissible 60 000 FCFA ; taux 80 %. Solution : $60\,000 \times 80\% = 48\,000$ FCFA. Le gestionnaire doit justifier la base retenue.

Cas 3 — Plafond presque épuisé

Données : plafond pharmacie 500 000 ; consommé 450 000 ; nouvelle base admissible 100 000 ; taux 80 %. Solution : base plafonnée à 50 000 ; remboursement 40 000.

Cas 4 — Droit expiré

Données : facture du 12 octobre ; radiation effective au 30 septembre. Solution : vérifier les clauses de maintien et la date de survenance des droits ; ne pas payer sur la seule présentation d'une carte.

Cas 5 — Pièce obligatoire absente

Données : prestation nécessitant une ordonnance selon le contrat ; ordonnance absente. Solution : mettre en attente et demander la pièce, plutôt que rejeter définitivement sans base.

Cas 6 — Doublon potentiel

Données : même assuré, même date, même prestataire, même montant, deux factures. Solution : blocage du doublon, rapprochement des références et demande de confirmation avant règlement.

Cas 7 — Hospitalisation

Données : facture admissible 2 M ; taux 90 % ; plafond 5 M. Solution : 1,8 M pris en charge, sauf exclusions/franchise/autres règles.

Cas 8 — EVASAN

Données : demande d'évacuation vers l'étranger. Solution : vérifier couverture territoriale, indication médicale, disponibilité locale selon le contrat, entente préalable, devis, plafond, transport et accompagnement ; décision traçable.

Cas 9 — Gros sinistre

Données : dossier dépassant le seuil d'alerte interne. Solution : signalement technique, vérification plafond/réassurance, suivi médical et financier renforcé.

Cas 10 — Prestataire à consommation atypique

Données : forte hausse d'actes par rapport à son historique. Solution : analyse comparative, échantillonnage des dossiers, contrôle médical/contractuel et plan d'action si anomalie confirmée.

Cas 11 — Ayant droit

Un enfant est ajouté au contrat après naissance. Contrôler le lien familial, les pièces, la date d'effet et les éventuels délais prévus. Ne pas créer l'ayant droit sans rattachement contractuel.

Cas 12 — Changement de catégorie

Un salarié passe d'une catégorie standard à une catégorie cadre avec garanties différentes. Le gestionnaire doit dater le changement, vérifier l'autorisation et activer les nouvelles garanties sans écraser l'historique.

Cas 13 — Renouvellement déficitaire

S/P élevé : analyser si la cause vient du niveau de garanties, de la population, de quelques gros sinistres, du réseau, des tarifs médicaux ou d'un problème de gestion. Ne pas appliquer une hausse uniforme sans diagnostic.

Cas 14 — Facture supérieure au devis

Comparer le devis autorisé à la facture finale. Identifier les actes supplémentaires, vérifier leur couverture et obtenir les validations prévues avant règlement.

Cas 15 — Double couverture

L'assuré déclare disposer d'une autre couverture. Ne jamais appliquer automatiquement une coordination : vérifier les clauses du contrat et les règles applicables avant de calculer la part due.

Cas 16 — Réclamation

Une prestation est contestée. Reprendre le dossier depuis les droits jusqu'au calcul, identifier la règle appliquée, produire une réponse motivée et conserver la trace de la réclamation et de son traitement.

PARTIE XIII — QCM DE MONTÉE EN COMPÉTENCE

1. Une facture médicale doit-elle être payée simplement parce que l'assuré est actif ?

Réponse : Non. Il faut contrôler la garantie, l'acte, les pièces, les plafonds et les autres règles applicables.

2. S/P = 70 % signifie-t-il automatiquement que le contrat est rentable ?

Réponse : Non. Il faut intégrer les autres charges et le contexte technique.

3. Une anomalie est-elle automatiquement une fraude ?

Réponse : Non. Elle justifie un contrôle.

4. Une carte de santé suffit-elle toujours à prouver un droit ?

Réponse : Non. Le statut réel et les règles de validité doivent être contrôlés.

5. Qui doit apprécier la nécessité médicale d'une chirurgie complexe ?

Réponse : le médecin-conseil ou l'instance médicale prévue par l'organisation.

6. Peut-on modifier un plafond pendant la liquidation pour faire passer une facture ?

Réponse : Non. Toute modification doit résulter d'une décision contractuelle autorisée et tracée.

7. Que doit contenir un bon rejet ?

Réponse : une motivation, une règle ou clause applicable, les éléments factuels et, si nécessaire, les voies de réclamation.

8. Quelle est la première question face à une EVASAN ?

Réponse : vérifier les droits et le périmètre contractuel, puis appliquer le processus médical et administratif prévu.

ANNEXE — CHECK-LIST DU GESTIONNAIRE SANTÉ

Avant validation	Oui / Non
Assuré identifié	☐
Contrat actif à la date des soins	☐
Garantie applicable	☐
Prestation couverte	☐
Pièces complètes	☐
Base admissible contrôlée	☐
Taux vérifié	☐
Plafond vérifié	☐
Franchise vérifiée	☐
Entente préalable vérifiée	☐
Contrôle médical effectué si nécessaire	☐
Doublon recherché	☐
Montant final recalculé	☐
Validation selon délégation	☐
Paieement traçable	☐

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES À SURVEILLER

- Code des assurances CIMA et ses modifications en vigueur.
- Règlements du Conseil des ministres des assurances, notamment les textes récents 2024-2026.
- Règlement relatif à la distribution et à la gestion du contrat par voie numérique/électronique.
- Règles nationales gabonaises applicables aux entreprises d'assurance, intermédiaires, données, santé et relations avec les organismes concernés.
- Conditions générales, conditions particulières, conventions de gestion et procédures internes de l'organisme.

Conclusion

Un excellent gestionnaire santé ne se contente pas de traiter vite. Il traite juste, traçable, conforme et compréhensible. Sa compétence repose sur la lecture du contrat, la compréhension du risque médical, la maîtrise des règles de calcul, le contrôle des pièces et la capacité à expliquer chaque décision.

Document préparé comme support de formation professionnelle — version 1.0 — Septembre 2026.